Ospedale dei Bambini Villa Flegrea
Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino
U.O.C. Pediatria e Diabetologia Pediatrica
Direttore: Dott. Gennaro Vitiello

Via Domitiana 77
80078 Pozzuoli
Reparto 081 5269301

Alla Dott.ssa Maria Grazia Iervolino
Pediatra di Libera Scelta
Bacoli

LETTERA DI DIMISSIONE

Esordio di diabete mellito tipo 1

DATI DEL PICCOLO PAZIENTE

Cognome e nome:	**Leonardo Esposito**	Data di nascita:	**21/04/2017**
Codice fiscale:	**SPSLRD17D21F839V**	Residenza:	**Via Fusaro 61, Bacoli**
Madre:	**Anna Cuomo - +39 333 418 0952**	Padre:	**Ciro Esposito**
Cartella:	**PED-25-01418**	Esenzione:	**013.250**

Ingresso: 03/11/2024 da Pronto Soccorso Pediatrico

Dimissione: 10-11-2024

Nosologico: 24PF0019833

Gentile Collega,
dimettiamo in data odierna il piccolo Leonardo, ricoverato il 3 novembre per poliuria, polidipsia, enuresi notturna secondaria e calo ponderale di circa 2 kg nelle ultime tre settimane, riferiti dalla madre, sig.ra Cuomo.

ANAMNESI

Nato a termine da parto eutocico, sviluppo psicomotorio regolare. Vaccinazioni secondo calendario. Non patologie di rilievo. Familiarità per tiroidite autoimmune (madre). Frequenta la seconda classe presso la Scuola Primaria Plesso Gianturco.

DECORSO CLINICO

All'ingresso il pz. si presentava disidratato (stimata 7%), con respiro di Kussmaul e alito acetonemico. Peso 22,4 kg, altezza 124 cm. Glicemia 486 mg/dL, emogasanalisi venosa con pH 7,18 e bicarbonati 9,4 mmol/L, chetonemia 4,8 mmol/L, quadro di chetoacidosi diabetica moderata.
È stato trattato secondo protocollo ISPAD con reidratazione endovenosa e infusione continua di insulina, con risoluzione dell'acidosi in 18 ore. Dalla seconda giornata terapia insulinica multiniettiva sottocute. Decorso successivo regolare, senza ipoglicemie gravi.
La coppia genitoriale ha seguito il percorso educativo strutturato con l'infermiera dedicata Rosaria Di Meo e la dietista (conteggio dei carboidrati, gestione di ipoglicemia e chetosi, uso del sensore). Il papà, sig. Esposito, ha eseguito in autonomia le somministrazioni dalla quinta giornata.

ESAMI PRINCIPALI

Esame	Risultato	U.M.	Riferimento	
Emoglobina glicata (HbA1c)	11,6	%	4,0 - 6,0	H
Peptide C	0,21	ng/mL	0,80 - 3,85	L
Anticorpi anti-GAD	86,5	UI/mL	< 5,0	H
Anticorpi anti-IA2	positivi		negativi	*
Anti-transglutaminasi IgA	0,6	U/mL	< 7,0	
TSH	2,14	µUI/mL	0,60 - 4,80	
Tipizzazione HLA	HLA-DQ2/DQ8 eterozigote			

DIAGNOSI DI DIMISSIONE

Diabete mellito tipo 1 all'esordio, chetoacidosi diabetica moderata risolta. Screening per celiachia e tiroidite negativo.

TERAPIA DOMICILIARE

Farmaco	Dose	Orari	Note
Insulina glargine 100 UI/mL	8 UI s.c.	ore 21	anche in caso di inappetenza
Insulina lispro 100 UI/mL	rapporto I/CHO 1:20	prima dei 3 pasti	correzione: 1 UI ogni 100 mg/dL sopra 150
Glucagone 1 mg spray nasale	1 erogazione	al bisogno	ipoglicemia grave con incoscienza
Glucosio in tavolette	15 g	al bisogno	glicemia < 70 mg/dL

CONTROLLI E INDICAZIONI

Prima visita presso il nostro Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica il 18.11.24 alle ore 9:30, con download dei dati del sensore. È stato consegnato il piano di gestione del diabete a scuola, da condividere con il dirigente scolastico e gli insegnanti per l'eventuale somministrazione di insulina in orario scolastico. Per ogni urgenza i genitori possono contattare la reperibilità diabetologica al numero del reparto indicato in intestazione.

Il Pediatra di Reparto

Dott.ssa Teresa Scotto di Carlo

PEDIATRIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA
Dott.ssa Teresa Scotto di Carlo
Ordine Medici NA n. 31877

Pozzuoli, 10/11/2024

Il Direttore

Dott. Gennaro Vitiello

Firma di un genitore per ricevuta:

_____